

Assessoria de Regionalização

1 Ata da 1ª Reunião da Plenária Ordinária AMPLIADA com Câmara Técnica da
2 Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea. Aos vinte e quatro dias do mês de
3 fevereiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e quarenta e cinco minutos, deu-se
4 início na Sede da CIR/BL a Primeira Reunião da Plenária Ordinária AMPLIADA com
5 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea de 2025,
6 contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
7 Janeiro (SES): Sr.^a Monique Zita dos Santos Fazzi, Representante Nível Central; Sr.^a
8 Karen Cristine Felix da Silva, Suplente Representante Nível Central; Sr.^a Simone
9 Machado de Azevedo, Secretária Executiva da CIR/BL; Sr. Anderson Pereira Ferreira,
10 Assistente da CIR/BL; Sr.^a Fernanda Veríssimo Santana, Assistente Administrativo de
11 Saúde da CIR/BL; Sr.^a Renata Ferreira N. de Oliveira, Assistente Administrativo de
12 Saúde da CIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Mario Jorge Lima
13 Espinhara, Secretário Municipal de Saúde de Araruama; Sr. Maxwel Sócrates dos
14 Santos Barbosa, Suplente e membro da Câmara Técnica da SMS Araruama; Sr.^a
15 Adriana Moutinho Amorim, Suplente e membro da Câmara Técnica da SMS de
16 Armação dos Búzios e membro da Câmara Técnica da SMS de Rio das Ostras; Sr. Jorge
17 Luiz Diniz Moura Filho, Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo; Sr.^a Nataly
18 da Rocha Queiroz, Suplente e membro da Câmara Técnica da SMS de Arraial do Cabo
19 e Articuladora do GC RUE da CIR/BL; Sr.^a Beatriz Cavalcante Trindade Marins,
20 Secretária Municipal de Saúde de Cabo Frio; Sr.^a Angélica Maurício Leitão da Cunha,
21 Suplente da SMS de Cabo Frio; Sr.^a Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia,
22 Secretária de Saúde de Casimiro de Abreu; Sr.^a Karin Netto de Castro, Secretária
23 Municipal de Saúde de Iguaba Grande; Sr. Cleber Geddes, Suplente e membro da
24 Câmara Técnica da SMS de Iguaba Grande; Sr.^a Rosimeri de Souza Azevedo, Suplente
25 e membro da Câmara Técnica da SMS Rio das Ostras; Sr. Marcelo Almeida Fonseca,
26 Suplente da SMS de São Pedro da Aldeia; Sr.^a Ana Paula Duarte, Suplente e membro da
27 Câmara Técnica da SMS de Saquarema. Do Conselho dos Secretários Municipais de
28 Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ): Sr.^a Adriana Moutinho Amorim. A Plenária
29 contou com a presença de nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo que cinco
30 Secretários de Saúde (Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e
31 Iguaba Grande). A Plenária contou com a presença de: Sr.^a Karla Valéria Barros
32 Tavares, Membro da Câmara Técnica da SMS Cabo Frio; Sr.^a Elisa de Oliveira Moreno,

Assessoria de Regionalização

Membro da Câmara Técnica da SMS de Casimiro de Abreu; Sr^a Tamires Rosa de S. Leite, membro da Câmara Técnica da SMS de Casimiro de Abreu; Sr. Alexandre Rodrigues da Costa, Membro da Câmara Técnica da SMS de São Pedro da Aldeia; Sr.^a Márcia Cristina Pereira de Souza da Costa, membro da Câmara Técnica da SMS de Saquarema e Articuladora do GT Regulação da CIR/BL; Sr.^a Vera Lúcia Ferreira da Silva Souza, Coordenadora da CIES/BL; Sr. Luiz Carlos Pimentel Aguiar, Coordenador do NDAVS/BL; Delcinéa Bastos, Técnica do NDAVS/BL; Sr.^a Alessandra Florim, Ponto Focal da CREG/BL; Sr.^a Francisca de Deus, SAPS/SES/RJ Apoiadora Regional SES; Sr.^a Fabiana Senna, Coordenação SAPS/SES/RJ; Sr. Marcelo Rodrigues de Castro, Superintendente SAECA/SES (virtualmente); Sr.^a Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva do CISBALI e técnica da CIR/BL; Sr. Marcelo Perelló, Diretor HSI- Onkosol; Sr.^a Roberta E. Borges, SESAU Araruama e Arianny de O. Ferreira, SESAU Araruama; Sra. Érika Souza, Beneficência Portuguesa, e Sr.^a Bianca Rocha Frederico, Articuladora do GC Rede Alyne e GC RCPD da CIR BL (virtualmente).

Apresentação: 1. Planificação da Atenção à Saúde - "PlanificaSUS" na Baixada Litorânea (SES/SUBVAPS). Sr.^a Erika se apresenta e informa que atuará como consultora no projeto. Em seguida, inicia a apresentação do Projeto Planificação da Atenção à Saúde, abordando os referenciais técnicos, operacionais e metodológicos relacionados à construção social da Atenção Primária à Saúde (APS). Destaca também os ciclos de melhoria e o modelo de trabalho do tutor no processo de planificação na região da Baixada Litorânea (BL). Sr.^a Erika solicita que o tema seja incluído como pauta permanente na CIR, para que seja possível acompanhar os resultados e realizar correções, caso haja necessidade. Informa ainda que, na Baixada Litorânea, os nove municípios aderiram ao projeto em 100%. As linhas de cuidado prioritárias definidas são Hipertensão e Diabetes. Apresenta o calendário de atividades, que prevê a realização de quatro oficinas ao longo deste ano, além de um webinar para compartilhamento de experiências. Sr.^a Fabiana distribui um livro do CONASS para cada município. Sr.^a Simone informa que necessita do envio dos nomes indicados para tutores municipais do projeto, destacando que, até o momento, apenas os municípios de Araruama e Iguaba Grande encaminharam as indicações. Sr.^a Monique solicita a confirmação dos tutores da SES: Sr.^a Francisca, Sr.^a Rita Vassoler, Sr.^a Michele e Sr.^a Eralda. **2.Cenário Epidemiológico, Situação das Arboviroses e outros informes**

Assessoria de Regionalização

(NDAVS/BL). Sr. Luiz inicia a apresentação falando sobre o Cenário Epidemiológico Dengue na Baixada Litorânea são 67 casos prováveis, 03 internações, 0 óbito em investigação e 0 óbitos confirmado. Com base no plano de contingência, para Enfrentamento às Arboviroses Urbanas causadas pelo Aedes Aegypti 2024-2026 no painel nível de alerta, diante dos números observados, todos os municípios estão no nível rotina. Os indicadores são monitorados semanalmente e a progressão para um novo Nível de resposta ocorre quando há aumento contínuo dos dados por três semanas consecutivas. Cenário Epidemiológico Chikungunya na Baixada Litorânea apresenta 0 casos prováveis, 0 internações, 0 óbitos em investigação e 0 óbitos confirmado. Cenário Epidemiológico Zika Vírus no Estado do Rio de Janeiro: 09 casos notificados, 0 casos confirmados e 09 casos descartados; Cenário epidemiológico; Oropouche na Baixada Litorânea: 02 casos notificados no e SUS-SINAN, 0 casos confirmados no e SUS-SINAN, 02 casos descartados no e SUS-SINAN, 0 óbitos em investigação e SUS-SINAN, 0 óbitos confirmados no e SUS-SINAN. Sr. Luiz segue apresentando o Plano de Contingência de Arboviroses onde, na Baixada Litorânea, os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e Saquarema estão atendendo a todos os critérios; São Pedro da Aldeia na 2ª versão com recomendações. Sr. Luiz apresenta o Plano de Contingência de Desastres: Os municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Araruama, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia e Saquarema atenderam todos os critérios; e Cabo Frio na 2ª versão com recomendações. Sr. Luiz finaliza com os informes: Oficina "Avaliar para Avançar" no dia 26/01/2026. (Gerência de Imunização / SES-RJ); A Gerência de Tuberculose (GERT/SES-RJ) realiza pesquisa sobre uso do Painel da Tuberculose. <https://forms.gle/4rEVasfeZ2qch6zHA>; Curso EAD Ovitrapas (5ª turma) de 02/02/26 a 06/02/26. SES-RJ, em 26/03, realizará uma reunião técnica para discutir sobre "novo indicador pactuado" (52) e nota-técnica da vigilância entomológica sobre ovitrampas e LIRAa. **I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2025.** A minuta da ata da 11ª Plenária Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2025, foi disponibilizada aos Gestores para sugestões, inclusões e revisões de texto. Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. **2. Inclusão do município de Rio das Ostras no programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família como campo prático (COOENS SES).** Sr.^a

Assessoria de Regionalização

Simone lembra que os municípios de Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia já possuem o programa implantado, informando que, agora, o município de Rio das Ostras também passa a integrar. Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. **3. Referendar a Deliberação Conjunta CIR/BL Nº 01 de 13 de janeiro de 2026 (CIR/BL).** Trata-se de pactuação para referendar/ratificar os pleitos dos componentes da Rede Alyne da Região de Saúde Baixada Litorânea. Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. **4. Referendar a Deliberação Conjunta CIR/BL Nº 02 de 29 de janeiro de 2026 (CIR/BL).** Trata-se de pactuação para referendar/ratificar a solicitação junto ao Ministério da Saúde (MS), de parcela suplementar, para custeio da Média e Alta Complexidade (MAC), no valor R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), destinado à Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu. Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. **5. Referendar a Deliberação Conjunta CIR/BL Nº 03 de 04 de fevereiro de 2026 (CIR/BL).** Trata-se de pactuação para referendar/ratificar no âmbito da Região de Saúde Baixada Litorânea, do estado do Rio de Janeiro, a aprovação dos recursos solicitados pelos gestores municipais, de parcelas suplementares, para o exercício de 2026, para custeio da Atenção Primária à Saúde e da Atenção a Média e Alta Complexidade, relacionados à Portaria GM/MS Nº 10.169/2026. Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. **6. Solicitação de recurso orçamentário para o custeio das ações de Média e Alta Complexidade - MAC de Casimiro de Abreu (SMS de Casimiro de Abreu).** Sr.^a Luciana apresenta a solicitação que está sendo realizada junto ao Estado para obtenção de recurso de Média e Alta Complexidade (MAC) destinado ao Hospital Municipal de Casimiro de Abreu. Informa que se trata de um hospital de porta aberta, que realiza atendimento de urgência e emergência a municípios vizinhos, gerando grande demanda e elevado custo para o município, sem que haja atualmente custeio por parte do Estado ou do Ministério da Saúde. Sr. Maxwell questiona se a pactuação é para atendimento regional ou se a solicitação é apenas de caráter local. Sr.^a Monique esclarece que o Estado precisa realizar a avaliação técnica e orçamentária antes de apoiar financeiramente alguma unidade ou programa. Informa que é feita uma análise técnica e de disponibilidade orçamentária, considerando o valor solicitado, o porte do hospital, se a unidade está prestando suporte regional ou não. Se a análise for favorável pode haver necessidade de reajuste do valor solicitado. Sr.^a Monique ressalta que esses critérios de análise devem

Assessoria de Regionalização

constar na pactuação. Sendo assim, as pactuações podem acontecer condicionadas a essas avaliações pela Secretaria de Estado de Saúde. Sr.^a Luciana informa que o repasse atual do Estado ao município de Casimiro de Abreu é de aproximadamente R\$ 12.000,00. Destaca que a solicitação de ampliação do recurso se faz necessária devido ao fato de o hospital absorver grande parte da demanda regional de urgência e emergência. Ressalta ainda que este é o primeiro pedido formal realizado pelo município ao Estado nesse sentido. Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. 7. **Solicitação de movimentação de PPI da SMS de Armação dos Búzios (SMS de Armação dos Búzios).** Sem nenhuma objeção, foi considerado pactuado. **Informes: 1. Situação da Rede de Oncologia na Baixada Litorânea (SMS Cabo Frio).** Sr. Marcelo Perelló inicia a apresentação falando da sua proposta junto ao Estado da criação de um Polo Diagnóstico para a região da Baixada Litorânea, mais precisamente, dentro do Hospital Santa Isabel, já que a unidade é a referência da região e por contar com profissionais especializados. Ele expõe um relatório dos últimos três meses revelando a situação do diagnóstico e o percentual de doença avançada bastante elevado, o que evidencia e significa que a região vem diagnosticando tardiamente seus pacientes. Sr. Marcelo Perelló diz que a principal causa do diagnóstico tardio é a dificuldade do exame final de biópsia ou a dificuldade de se estabelecer como um caso realmente suspeito. Ele finaliza dizendo que o Centro de Oncologia está à disposição do ponto de vista técnico, de acompanhamento e desenvolvimento desse projeto, mas precisa da participação ativa dos gestores para viabilizar o projeto. Sr.^a Monique segue com o assunto seguinte deste informe sobre o retorno do atendimento oncológico em cabeça e pescoço e passa a palavra ao Sr. Marcelo Rodrigues. Ele diz que na última CIB foi pactuado incentivo para o Onkosol no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, como forma de incentivo, para dar continuidade ao procedimento de cirurgia de cabeça e pescoço na região. Um remanejamento do recurso MAC da gestão estadual para o teto financeiro MAC do município de Cabo Frio e que este vigora a partir do teto financeiro de março. Sr. Marcelo menciona que o estadiamento do câncer é muito alto dentro do Estado do Rio de Janeiro e que um polo diagnóstico há de se considerar também pela política do Ministério da Saúde e fazer mais OCIs oncológicas dentro do Estado, porque esse recurso é um recurso extra que cai diretamente no FAEC dos municípios. Sr.^a Monique diz que é interessante que o diagnóstico seja realizado no

Assessoria de Regionalização

UNACOM, uma vez que concentra os exames e os profissionais especializados e sugere uma conversa entre Município de Cabo Frio, UNACOM e SAECA para afinar essa organização e captar esse recurso. Sr.^a Ana Paula toma a palavra e diz que além de investir na referência regional também se poderia estudar a participação do consórcio, como facilitador do diagnóstico. Sr.^a Adriana menciona a necessidade de fazer um plano de distribuição de recursos das OCIs, porque o recurso está sendo fragmentado nas Emendas Parlamentares. Sr.^a Monique diz que mesmo com a possibilidade de obtenção de recursos novos, por meio desse programa, deve ser identificada a capacidade de ampliação de oferta do UNACOM para absorver essas novas demandas. Sr.^a Rosimeri acrescenta a necessidade de cada município apresentar os procedimentos que pode executar. Sr.^a Monique propõe como encaminhamento do assunto abordado, fazer um estudo regional unificado, incluindo a possibilidade de participação do Consórcio para fazer exames complementares, desenhando a proposta com dados mais detalhados. Sr. Marcelo destaca que a Baixada Litorânea mediante dados apresentados do Sr. Marcelo Perelló, onde o indicador revela que o estadiamento está muito alto na região e é preocupante e demonstra que o Onkosol não está absorvendo a demanda, então, sugere começar com o que é viável dentro das OCIs e utilizar as cirurgias eletivas, principalmente municípios que tem unidade própria. Ele diz que quanto ao recurso de emendas serem direcionado para o consórcio, ainda não tem conhecimento, mas vai estudar sobre o assunto. Ele destaca ser primordial investir na atenção primária à saúde, quanto à prevenção, antes que o paciente entre no estadiamento. Sr.^a Monique passa para o próximo assunto sobre o Fluxo assistencial e atendimento aos pacientes com neoplasias de Tórax e descontinuidade do atendimento a pacientes com neoplasias de Tireoide e passa a palavra ao Sr. Marcelo Perelló. Ele menciona sobre reuniões que houve com o município de Cabo Frio e com a gestão estadual e a ideia é: pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, que passou por uma consulta cirúrgica com cirurgião torácico e foi descartada a cirurgia, a quimioterapia fosse para o Onkosol. Esse foi o acertado no Estado e com a presença da Sr.^a Kitty. Sr.^a Alessandra diz que a SES já habilitou a Onkosol no sistema para disponibilizar a agenda e começar a regular os pacientes de torácica. Sr. Marcelo Rodrigues diz que já foi sinalizado para dar continuidade ao cofinanciamento dentro do Estado e que vai pagar o que extrapolar o teto financeiro. Sr.^a Karla questiona se extrapolar o cofinanciamento, pois a

Assessoria de Regionalização

determinação ainda não saiu, se consegue aumentar o valor que recebe. Sr. Marcelo esclarece que até quinhentos mil/mês certamente vai cobrir o cofinanciamento, mas se for um pouco mais, poderá fazer os estudos e levar a proposta para a Subgeral da SES. Ele frisa que radioterapia é valor FAEC e o Ministério da Saúde retirou recurso de Cabo Frio no mês de janeiro do FAEC pelo SISMAC, devido à portaria de radioterapia. Sr^a. Monique busca saber do Sr. Marcelo Rodrigues sobre a descontinuidade do atendimento ao paciente com neoplasia de tireoide e o Sr. Marcelo diz não ter essa informação no momento. Sr^a. Alessandra toma a fala e diz que os pacientes de tireoide, que não tinham mais oferta no Onkosol, vêm sendo regulados para os prestadores da Capital. Sr. Marcelo Perelló esclarece que em dado momento de muita demanda da região, absorveu alguns pacientes, mas a unidade só realizava as cirurgias e não o tratamento. Ele relata que é um custo alto, uma demanda elevada e esse paciente necessitam de acompanhamento de um especialista, o que não era viável para a unidade. Sr^a. Monique diz que é necessária uma reunião com as várias áreas: SAECA, Regulação e com Município de Cabo Frio para encontrar uma solução. Sr^a. Alessandra informa que os pacientes devolvidos de cabeça e pescoço, que os municípios tinham inserido para a nova regulação, num acordo junto com a Onkosol, foram reagendados e absorvidos por esta unidade.

2. Diminuição da oferta de insumos para coleta de exames citopatológicos (GC Rede Alyne). Sr^a. Bianca relata que, desde dezembro, os municípios foram informados pelo laboratório de que haveria redução na quantidade de insumos distribuídos. Diante da situação, entrou em contato com a Sr^a. Natami, da SES, responsável pelo SISCAN, que informou que verificaria a questão junto à área técnica. Segundo as informações repassadas, o laboratório já havia sinalizado dificuldades relacionadas a recursos financeiros, em razão de débitos referentes aos anos de 2024 e 2025. Sr^a. Bianca esclarece que, em nenhum momento, o laboratório deixou de realizar as análises dos exames preventivos; no entanto, os municípios que dependem do fornecimento desses materiais passaram a ser prejudicados. Ressalta ainda que, desde dezembro, houve uma redução significativa na quantidade de insumos disponibilizados, o que impacta diretamente na coleta dos exames, considerando a necessidade de ampliar a realização de preventivos para garantia do cuidado e cumprimento dos indicadores de saúde. Sr^a. Beatriz informa que já foi realizado o acerto referente à atual gestão e que a situação que havia gerado bloqueio já foi regularizada. No entanto, destaca que ainda

Assessoria de Regionalização

225 existe uma dívida referente ao ano de 2024, com valores elevados, razão pela qual ainda
226 não foi apresentado um plano com datas para pagamento. Sr.^a Rosimeri relata que o
227 serviço só não foi interrompido porque o município realizou a compra de materiais por
228 conta própria. Sr.^a Beatriz reforça que a situação referente a 2025 já foi regularizada,
229 mas afirma que, neste momento, não pode garantir o pagamento dos débitos de 2024,
230 uma vez que há outros prestadores com valores ainda mais elevados na relação de
231 débitos. Sr.^a Bianca acrescenta que o Estado solicitou que fosse sinalizada a situação
232 atual da região, de forma a apresentar um panorama do cenário enfrentado pelos
233 municípios. Reitera que, infelizmente, a redução no fornecimento de materiais impacta
234 diretamente na coleta dos exames preventivos. Destaca ainda que, mesmo com alguns
235 municípios realizando a compra de insumos, está difícil adquirir os materiais
236 necessários. Por fim, Sr.^a Beatriz se prontifica a dialogar com o prestador, buscando a
237 normalização do fornecimento dos insumos, considerando que os débitos referentes a
238 2025 já foram acertados. **3. Atualização de informações referente à implantação do**
239 **Programa Agora Tem Especialistas (GC PATE/BL).** Sr.^a Natália informa que
240 ocorreu a reunião do GC PATE, na qual foi comunicado que Sr. Samuel não poderá
241 mais permanecer à frente da articulação do grupo e também está se desligando do NAG.
242 Diante disso, a articulação do grupo passará a ser conduzida pela Sr.^a Monica
243 Gonçalves, e a relatoria ficará sob responsabilidade da Sr.^a Thaynara, do município de
244 Armação dos Búzios. Na sequência, Sr.^a Natália fala sobre uma apresentação do NAG
245 referente à execução das OCIs, destacando que os dados demonstram baixa execução na
246 área de oncologia e, de modo geral, nas demais especialidades. Informa ainda que o
247 NAG iniciará visitas aos municípios com o objetivo de dar continuidade ao processo de
248 implantação do programa. **4. Situação da Rede de Urgência e Emergência da**
249 **Baixada Litorânea (GC RUE).** Sr.^a Nataly informa que ainda não houve reunião do
250 GC RUE neste ano. Relembra aos municípios que foi pactuado na reunião do CISBALI
251 que as bases descentralizadas devem ser construídas até o meio do ano. **5.**
252 **Planejamento Regional Integrado da Baixada Litorânea (AR/SES).** Sr.^a Monique
253 fala sobre o câncer de mama e relembra que foi pactuado um plano para organizar essa
254 linha de cuidado. Informa que não há novos informes no momento, pois a equipe esteve
255 focada na Rede Alyne e no processo de repactuação ao qual prestaram apoio.
256 Acrescenta que, a partir do mês de março, será iniciada, de forma conjunta, a execução

Assessoria de Regionalização

dos pontos pactuados, incluindo as metas da matriz DOMI, acordadas no ano passado.

6. Comunicado SES/ASSRBL Nº 02/2026 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sr.^a Simone destaca que o GC RCPD não conseguiu

realizar reunião por falta de quórum e solicita aos municípios maior organização e participação no grupo, ressaltando que se trata de uma pauta que está sob atenção do Ministério Público. Informa que o grupo se encontra em fase de atualização do plano, porém não tem conseguido avançar devido à ausência de reuniões. GT Assistência Farmacêutica também não conseguiu se reunir, em razão da véspera do Carnaval e das dificuldades de acesso, sendo necessário cancelar o encontro. GC da Rede Alyne, informa que o grupo ainda está trabalhando na elaboração do material do fórum que será apresentado aos gestores. Acrescenta que o grupo está solicitando a presença das Áreas Técnicas da Violência (NESPAV) e Saúde da Mulher para realização de uma reunião ampliada para discutir o tema do aborto legal, considerando as dificuldades enfrentadas pelos municípios para a execução desse serviço.

7. Informes CISBALI. Sr.^a Natalia fala sobre a situação da adimplência no âmbito do CISBALI, informando que os municípios inadimplentes são Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras. Aborda também a situação das assinaturas dos contratos de rateio para o ano de 2026, relatando que já foram recebidos os documentos assinados pelos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu e Saquarema, permanecendo pendentes as assinaturas dos prefeitos de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia. Informa ainda sobre os recursos da Educação Permanente e do PlanejaSUS, destacando que os municípios de Rio das Ostras e Iguaba Grande ainda não realizaram o repasse. Acrescenta que o consórcio segue aguardando o recurso de incentivo da SES destinado à CRUR/SAMU 192 – RUE. Relata que o consórcio vem sendo acionado pelo Ministério Público com cobranças relacionadas à Central de Regulação, ressaltando as dificuldades enfrentadas para o avanço dessa pauta em razão da falta de recursos, decorrente da inadimplência de alguns municípios. Informa também que, recentemente, a equipe do consórcio esteve em reunião com representantes do Tribunal de Contas do Estado, que comunicaram que, a partir do próximo ano, serão realizadas visitas aos municípios para verificar como estão conduzindo as questões relacionadas ao consórcio e os motivos pelos quais não estão cumprindo com o pagamento do rateio. Na sequência, Sr.^a Adriana informa que o município de Armação

Assessoria de Regionalização

dos Búzios está com processo parado desde outubro, apesar de já ter cumprido uma extensa lista de exigências referentes ao projeto de incentivo às bases do SAMU, permanecendo, ainda assim, sem parecer do Estado. Diante disso, Sr.^a Natalia informa que levará essa situação ao Sr. Lenini. Sr.^a Natalia também aborda a indicação dos membros para o Conselho Fiscal do consórcio, informando que ainda faltam as indicações dos municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Iguaba Grande. Solicita que os municípios encaminhem ofício ao consórcio com a indicação contendo nome, CPF, telefone e e-mail para contato, pelo endereço eletrônico cisbali@gmail.com. Informa ainda que o CISBALI foi contemplado com recursos para a realização de cirurgias eletivas de média complexidade, conforme a Resolução SES nº 3.926/2025. Apresenta também o Ofício nº 089/2026 – 3ª PJT/COCFR, referente ao cadastro no TCE/RJ da unidade gestora no sistema SIGFIS. Por fim, informa que, para o presente ano, será realizada apenas uma assembleia do consórcio, prevista para ocorrer entre o final de maio e o início de junho. Na ocasião, serão discutidos os seguintes pontos: revisão estatutária, situação da CRUR/SAMU, contratos de rateio para 2027, orçamento para 2027 e as eleições para o biênio 2027–2028. **8. Outros informes CIB e COSEMS-RJ.** Sr.^a Adriana informa que, na última semana de janeiro, foi aberta a aba do sistema DigSUS para inserção dos Planos Municipais de Saúde. Relata ainda que o município de Armação dos Búzios recebeu um comunicado de auditoria do Tribunal de Contas referente ao InvestSUS e que, possivelmente, os demais municípios da região também deverão receber comunicados semelhantes. Destaca que, na elaboração do Plano Municipal de Saúde, é importante que as metas estejam compatíveis com a captação de recursos provenientes de emendas parlamentares e das portarias dos programas do Ministério da Saúde. Informa também sobre o sistema SIOPS, cujo prazo de fechamento estava previsto para o mês de janeiro, mas foi prorrogado até o dia 2 de março. Relata que o registro do CEO e do Laboratório Regional de Prótese Dentária passou a ser realizado no sistema SUS APS. Quanto aos recursos das OCI, menciona que alguns gestores têm relatado, nas assembleias, que não estão recebendo esses recursos. Esclarece que parte do recurso foi recebido de forma antecipada e que precisa ser abatido, ressaltando que, na região, nenhum município alcançou o percentual de 30%, sendo realizadas também captações por meio de emendas parlamentares. Por fim, informa que os municípios não receberão novos

Assessoria de Regionalização

recursos do Ministério da Saúde enquanto não houver a devida prestação de contas e
quitação da utilização dos recursos provenientes das emendas parlamentares. Nada mais
a tratar, eu, Simone Machado de Azevedo, Secretária Executiva da CIR Baixada
Litorânea, dei por encerrados os trabalhos às 12 horas e 10 minutos e lavrei e assinei a
presente Ata. São Pedro da Aldeia, 24 de fevereiro de 2026.

Monique Zita dos Santos Fazzi

Representante Nível Central da SES

Mario Jorge Lima Espinhara

Secretário de Saúde de Araruama

Jorge Luiz Diniz Moura Filho

Secretário de Saúde de Arraial do Cabo

Beatriz Cavalcanti Trindade Marins

Secretária de Saúde de Cabo Frio

Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia

Secretária de Saúde de Casimiro de Abreu

Karin Netto de Castro

Secretária de Saúde de Iguaba Grande